

첫 번째 강의

1. 활력 징후 측정 (체온, 호흡수, 심박수, 혈압)

(1) 체온

구강체온 36-37

액와체온 35.5-36.5

직장체온 36.5-37.5

고막체온 36.5-37.5

● 고막 체온계 사용하는 경우

- 양쪽 고막을 측정 (오차 확인)
- 고막 방향 (귀를 후방으로 견인)

(2) 혈압

자동 혈압계와 수동 혈압계로 나뉨

수축기 / 이완기 두 구간 측정

수동혈압계 + 청진기

- 상완동맥 측정
- 화이트가운 증후군
- 5분 안정 & 이완 후 측정
- 팔의 높이 커프 위치

- 가압은 최대한 빠르게
- 감압은 적당히 (초당 2-3mmHg)

(3) 심박수

주로 요골동맥

경동맥, 측두동맥, 상완동맥

대퇴동맥, 족배동맥

30초 측정 후 X 2

(4) 호흡수 (가장 까다로움)

가슴 배 등 (+ 어깨)의 움직임 확인

누워서 측정할 경우 약간 용이

환자가 인식하지 못하게 측정

-> 심박수를 재면서 동시에 호흡수를 재라.

30초 측정 후 X 2

간호학 실습 동영상

상황: 양측 외이도염 및 화농성 중이염으로 외래를 통해 입원한 김이빈 님을 병실로 (F/23) 안내한 후 기초사정을 위해 활력징후를 측정하려 한다 절차에 맞게 수행해 보시오.

1. 준비

- ① 물품 준비 전 손을 씻는다.
- ② 필요한 물품을 준비한다.
초침이 있는 시계 / 쟁반 / 전자체온계 / 수은 / 혈압계 / 청진기 / 소독솜 / 손소독제 / 간호기록지(TPR sheet) / 종이타월 (액와가 축축한 경우)
- ③ 전자 체온계를 꺼내어 끝 부분을 소독솜으로 닦는다.
- ④ 전자 체온계의 작동을 확인한다.
- ⑤ 청진기 귀꽃이를 소독 솜으로 닦는다.
- ⑥ 혈압계가 제대로 작동하는지 확인한다.
- ⑦ 간호사 소개
- ⑧ 대상자 확인 (개방형 질문 / 팔찌 확인)
- ⑨ 활력징후 측정 (액와 체온 / 맥박 / 호흡 / 혈압) 목적과 절차를 설명
- ⑩ 손 소독제로 손 위생 실시

2. 체온, 호흡 측정

2-1. 액와 체온 측정

- # 액와가 축축한지 확인 (축축하면 종이 타월로 닦아서 건조시킴)
- # 체온계 끝의 체온감지 부분을 겨드랑이 중앙에 삽입
- # 대상자에게 체온 측정하는 동안 체온계가 삽입된 반대편 손으로 어깨를 잡고 있어야함을 설명
- # 대상자가 액와 체온 측정에 대해 질문할 경우 이유를 설명해준다.

-> 외이도염, 중이염이 있어 체온이 정확하지 않고 염증 자극 가능

- ① 체온계를 삽입하고 기다리는 동안 맥박 호흡을 측정
- ② 이불을 내려 가슴이 보이도록 함
- ③ 2,3,4번째 손가락으로 요골동맥을 짚고 살짝 누름
- ④ 처음 입원 시 1분 측정
규칙적임을 확인 후 30초 측정 후 2배
- ⑤ 맥박을 측정하는 동안 손을 동맥에 그대로 올려둔 채로 환자가 눈치채지 않게 호흡 측정
- ⑥ 측정 체온 메모하기
- ⑦ 소독솜으로 체온계 닦은 후 용기에 넣기
- ⑧ 손 위생 실시

2-2. 고막 체온 측정

- ① 체온계에 탐침 덮개를 씌움
- ② 대상자의 머리를 한쪽으로 돌리고 성인은 귓바퀴를 후상방, 소아는 후하방으로 당긴 후 삽입
- ③ 체온이 표시되거나 삐 소리가 나면 빼기
- ④ 측정 체온을 메모하기

2-3 호흡 측정

- ① 처음 입원 시 1분 측정
규칙적임을 확인 후 30초 측정 후 2배
- ② 대상자가 눈치채지 않게 확인

3. 혈압 측정

- ① 목적 설명
- ② 대상자의 상태를 확인한 후 편안한 자세를 취하게 함
- ③ 옷을 팔 위로 완전히 올리고 팔을 심장과 같은 높이에 오게 함
- ④ 2,3 or 2,3,4 손가락으로 상완 동맥을 찾기
- ⑤ 커프를 상완동맥 2~3 cm 위에 손가락 하나 들어갈 정도의 여유를 남기고 감음
- ⑥ 한손으로 혈압계 조절 밸브를 잠그고 요골동맥을 촉진하며 압력밸브를 눌러 커프에 공기 주입
- 이때 다른 손의 2,3 손가락으로 상완 요골 동맥을 촉진하여 맥박이 소실되는 곳에서 조금 더 압박을 올림 (30mmHg 높게)

- 2mmHg/초의 속도로 압력이 내려가도록 풀면서 상완동맥이나 요골동맥에서 다시 맥박이 들려올 때까지 측정
- 커프의 공기를 뺀 후 최소 15초 동안 기다림 (간격 두기)
- 상완동맥 위에 청진기를 놓고 움직이지 않도록 손으로 고정하기
- 맥박 촉진 지점보다 30mmHg 높게 커프 공기를 주입함
- 조절밸브를 천천히 열어 똑같이 진행
- ⑦ 커프의 공기를 완전히 뺀다.
- ⑧ 대상자 팔에서 커프를 풀고 대상자가 옷을 입는 것을 도와줌
- ⑩ 커프를 말고 혈압계를 정리
- ⑪ 측정한 혈압을 메모함
- ⑫ 청진기의 귀꽃이를 소독솜으로 닦기
- ⑬ 손 씻기
- ⑭ 측정 결과를 기록지에 기록하기

경희 의료원 영상 - [족배 혈압 측정 방법]

-> 팔에서 혈압을 잴 수 없거나 팔의 혈압과 비교하는 경우에 사용

- ① 손을 씻고 물품 준비
- ② 환자 확인 후 설명
- ③ 환자가 양와위를 취하도록 함
- ④ 커프가 복사뼈를 덮도록 발목에 감음
- ⑤ 2, 3 손가락으로 족배동맥을 찾아 혈압 측정

⑥ 이후는 팔의 혈압 측정법과 동일

(이외의 동영상들은 위의 영상에 모두 포함되는 내용들이거나, 아예 수업 내용과는 별 관계 없는 영상들이기에 따로 요약하지는 않겠습니다. 궁금하시면 따로 시청해보시는걸 추천드립니다.)

2. 맥진 술기 (진단학 실습 지침서 5페이지 참조 - 관련 내용은 파란색으로 첨부 / ppt 내용 및 영상 내용은 검은색)

- ① 인사를 하고 소속과 신분, 이름을 밝힌 후 맥진을 하겠다고 말하고 동의를 구한다.
- ② 환자를 편안한 자세로 앉게 하고 안정된 상태를 유지하게 한다.
-> 만일 환자가 불안한 상태라면 안정될 때까지 기다린 후 맥진을 시행한다.
- ③ 환자에게 외투 등 겹옷을 벗고 소매를 척맥 부위 이상으로 걷어 올리도록 한다.
- ④ 환자에게 맥진 시 주의사항을 숙지시킨다.
-> 손목의 높이가 심장과 비슷한 위치에 있게 한다.
- ⑤ 환자의 오른쪽 팔을 펴서 손바닥이 위를 향하고, 손가락은 자연스럽게 펴도록 하여 손목 받침대 위에 놓는다.
- ⑥ 손목을 감싸쥐듯 촉지하며 왼손 가운데 손가락으로 환자의 오른손 관맥을 찾는다.
- ⑦ 왼손 둘째 손가락으로 환자의 오른손 촌맥을 찾고, 넷째 손가

락으로 환자의 오른손 척맥을 찾는다.

-> 골도법에 따라 환자의 팔 길이에 따라 적절하게 촌관척을 찾아야 한다.

⑧ 촌관척 위에 놓인 손가락에 살짝 힘을 주어 맥진을 한다.

⑨ 왼손 둘째 손가락으로 환자의 촌부를 깊게 누른 후 천천히 떼면서 맥상을 살핀다.

⑩ 왼손 가운데 손가락으로 환자의 관부를 깊게 누른 후 천천히 떼면서 맥상을 살핀다.

⑪ 왼손 넷째 손가락으로 환자의 척부를 깊게 누른 후 천천히 떼면서 맥상을 살핀다.

⑫ 환자의 왼쪽 팔을 펴서 손바닥이 위를 향하고, 손가락은 자연스럽게 펴도록 하여 손목 받침대 앞에 놓는다.

⑬ 손목을 감싸쥐듯 촉지하며 오른손 가운데 손가락으로 환자의 왼손 관맥을 찾는다.

⑭ 오른손 둘째 손가락으로 환자의 왼손 촌맥을 찾고 넷째 손가락으로 환자의 왼손 척맥을 찾는다.

⑮ 촌관척 위에 놓인 손가락에 살짝 힘을 주어 맥진을 한다.

⑯ 오른손 둘째 손가락으로 환자의 촌부를 깊게 누른 후 천천히 떼면서 맥상을 살핀다.

⑰ 오른손 가운데 손가락으로 환자의 관부를 깊게 누른 후 천천히 떼면서 맥상을 살핀다.

⑱ 오른손 넷째 손가락으로 환자의 척부를 깊게 누른 후 천천히 떼면서 맥상을 살핀다.

-> 진찰하는 손은 환자의 손과 반대쪽 손이어야 한다.

-> 손 끝에 주어진 힘이 너무 강하거나 너무 약하지 않아야 한다.

⑮ 맥진 총 시간은 최소 1분 이상이 되어야 한다.

⑯ 맥진이 완료되면 진료기록부에 기재한다.

⑰ 진찰이 끝났음을 알리고 감사를 표현한 후, 결과에 대해 요약 설명한다.

(1) 맥진 자세

① 안정된 자세 (2분 이상 고정되어야 하니 편한 자세)

② 손목은 심장과 같은 높이

③ 손목 노출 (압력은 없어야 함)

(2) 촌관척 정위 (한의진단학실습 군자출판사 103~104 page 참조)

(3) 맥상 기술: 진단학 실습지침서 맥진 표 참조

(4) 맥진 기타 주의 사항

① 왼손은 오른손, 오른손은 왼손으로 진찰

②指尖의 가장 예민한 부위로 절진

③ 동맥의 방향에 맞게 촌관척 정위 (일직선일거라고 생각하지 않는 것이 매우 중요)

④ 총간 (전체) 후 단간 (촌관척) -> 단간보다는 총간에 집중

⑤ 판단 기준에 따라 구분

- 지/삭, 부/침, 대/세, 장/단

- 규칙/불규칙

- 유력/무력

⑥ 맥진 시간은 최소 1분 이상 (교수님 생각엔 2분)

⑦ 좌우맥의 비교

- 지/삭, 부/침, (+ 대/세, 장/단)

- 혈관 압박 요인 고려 (젊은이의 경우 대부분 상완 신경총 부위가 눌러 있거나 팔꿈치나 손목의 문제 등)

촌관척 정위 (한의진단학실습 군자출판사
103~104 page 참조)

(1) 기준점 확인

- ① 요골경상돌기(styloid process of radius) (이하 ‘高骨’)
- ② 해부학적코담배갑(anatomical snuffbox)
- ③ 주상골결절(tubercle of scaphoid)
- ④ 요골동맥(radial artery)
- ⑤ 제1중수골(1st metacarpal bone)



(2) 자세

- ① 적절한 팔꿈치와 손목의 자세를 찾기 위해 앉은 자세에서 팔꿈치가 실습테이블에 닿게 하고 아래팔을 바닥에 대어 해부학적 코담배갑이 위로 가도록 팔을 자연스럽게 앞으로 편다.
- ② 제1중수골의 근위부와 高骨을 연결한 선이 아래팔과 수평이 되도록 하고, 그 자세에서 손가락은 힘을 빼서 자연스럽게 구부러진 상태가 되게 한다.
- ③ 이때 손목의 높이는 심장과 같은 높이에 올 수 있도록 하고, 필요하면 손목 밑에 적당한 쿠션을 두어 손목을 편안하고 자연스럽게 한다.

(3) 촌관척 정위

- ① 高骨의 약간 근위의 전방향의 돌출된 뼈의 능선을 찾고 그 부위의 요골동맥 부분을 관부(關部)로 표시한다.
- ② 高骨에서 완관절 횡문까지의 거리를 측정하여 이 길이를 1寸으로 가정하고 관부(關部)에서 원위방향으로 6分 진행하여 촌부(寸部)를 표시한다.
- ③ 高骨에서 주관절 횡문까지의 거리를 측정하여 1尺으로 가정하고 관부(關部)에서 근위방향으로 6.5分 진행하여 척부(尺部)를 표시한다.

(4) 촌관척 촉진

- ① 왼손으로 환자의 오른손을, 오른손으로 환자의 왼손을 진찰할 수 있도록 자리 잡는다.

② 2,3,4指 세 손가락을 활모양으로 약간 구부리고 손가락 끝을 수평으로 하되 손가락의 가장 예민한 끝부분(指腹)을 이용하여 피 실습자(환자)의 요골동맥을 촉진 할 수 있도록 한다.

③ 먼저 3指로 관부(關部)를 촉진하고, 이어서 2指와 4指로 각각 촌부(寸部)와 척부(尺部)를 촉진한다



④ 왼손으로 환자의 오른손을, 오른손으로 환자의 왼손을 진찰할 수 있도록 자리 잡는다.

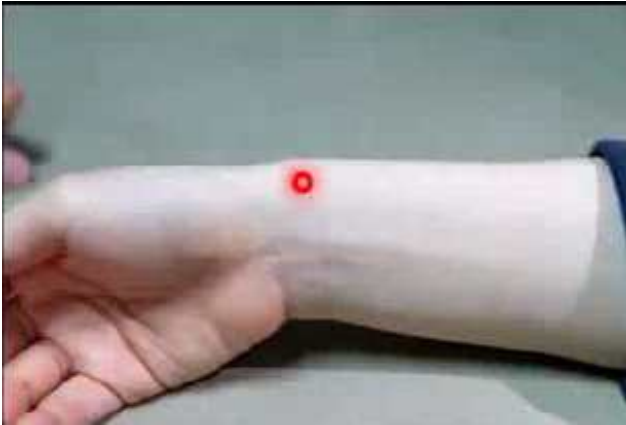
⑤ 2,3,4指 세 손가락을 활모양으로 약간 구부리고 손가락 끝을 수평으로 하되 손가락의 가장 예민한 끝부분(指腹)을 이용하여 피 실습자(환자)의 요골동맥을 촉진 할 수 있도록 한다.

⑥ 먼저 3指로 관부(關部)를 촉진하고, 이어서 2指와 4指로 각각

촌부(寸部)와 척부(尺部)를 촉진한다.

맥진의 과정

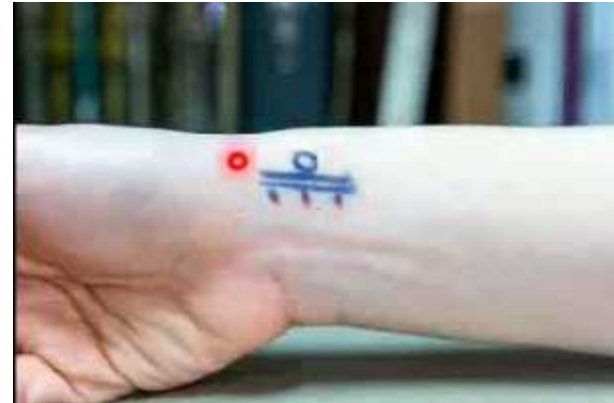
1. 고골 (경상돌기) 찾기



2. 그 아래의 동맥을 찾음 (개인차가 있으니 주의)



3. 고골 아래쪽을 박동처를 찾고 이를 관으로 정함. 관 위쪽을 손 팔꿈치 방향을 척이라고 생각하기 (초기에는 표시하는게 중요, 익 숙해지면 관을 찾고 그것을 기반으로 손과 척을 찾음)



맥진의 자세

손에서 가장 예민한 부위인 곳 (검은색 표시)으로 혈관을 찾기



다음과 같은 손 모양으로 혈관을 찾기 (2지-손/3지-관/4지-척)



종합)

3지의 가장 예민한 부분이 관에 닿도록 하고, 이에 맞춰 손과 척도 설정

혈관의 모양이나 위치에 따라 손, 관, 척의 위치가 조금씩 바뀔 수 있음

항상 일관된 자세로 남의 맥이든 나의 맥이든 맥을 잡기



설진 술기(진단학실습 지침서 6페이지 참조)

- ① 필요한 물품(설압자 등)을 준비한다.
- ② 설진 전 외부의 유색광을 차단한다.
 - * 진료환경 가운데 색깔이 있어 설진에 방해가 되는 물건을 없앤다.
- ③ 환자에게 인사를 하고 자신을 소개한다.
- ④ 환자의 이름, 나이를 질문하여 확인한다.
- ⑤ 환자에게 설진을 하는 목적과 절차를 설명한다.
- ⑥ 손을 씻는다.
- ⑦ 혀에 색소가 침착되는 음식을 섭취했는지 확인한다.
 - * 섭취 시 설진을 할 수 없으므로 다음으로 미루고 다음 설진을 받을 때 이런 음식을 먹지 않도록 지도한다.
- ⑧ 환자를 편한 자세로 의자에 앉히고 얼굴은 정면을 향하게 한다.
- ⑨ 환자에게 입을 벌리고 자연스럽게 혀를 내밀어 보라고 한다
 - * 설면은 편평하게 설첨은 약간 아래를 향하도록 설체가 충분히 노출되도록 지도한다.
- ⑩ 설질의 색조(담백, 담홍, 홍, 적자, 암적 등)를 관찰해 기록한다.
 - * 이때부터는 진단 내용이 들어가고 준비된 표준화 사진을 컴퓨터 화면을 통해 보여주며 선택하도록 한다.
- ⑪ 설질의 형상 (위축, 비대, 치흔 유무)를 관찰해 기록한다.
- ⑫ 설질의 윤택여부 (건조, 윤택)를 관찰해 기록한다.

- ⑬ 설질의 색조(백태, 황태, 흑태 등)를 관찰하여 기록한다.
- ⑭ 설질의 형상(박태, 후태, 이태 등)를 관찰하여 기록한다.
- ⑮ 설진이 완료되면 검사가 끝났다고 설명한다.
- ⑯ 환자에게 진찰 결과를 요약하여 설명해준다.

(1) 설진 환경

- 조명, 의자, 설압자 등이 필요
- 사전 염태 확인 (음식, 음료수, 초콜릿, 커피)

(2) 설진 자세: 진단학1 설진 부분 참조

(3) 설진내용 기술: 진단학 실습 지침서 설진표 참조

- 설체 운동성, 설태, 설하락맥 등

(4) 설진 기타 주의 사항

- ① 최대한 자연광에 가까운 조명 사용 (유색광 X)
- ② 설체의 운동성도 파악 (잘 움직이는지 등)
- ③ 설진과 함께 파악해야 할 사항
(구취, 진액의 운조, 치아 상태, 턱관절 및 구강의 운동성, 입술 주위상태, 구강 내부의 수포, 염증 등)
- ④ 필요한 경우 설압자를 사용

안면부 진찰

① 안면부 특징 (모발 염증 흉터 관찰)

② 안면부 대칭

-> 좌우가 중심 선상을 기준으로 대칭이 잘 되어 있으면 건강하다고 판단

③ 턱관절 운동 촉진

④ 안구운동검사 + 빛을 비추어서 동공반응검사

⑤ 구개인후부 관찰

두경부 진찰

① 두경부 정위 (머리가 어떻게 위치해있나)

② 두경부 움직임

경향부 구조물

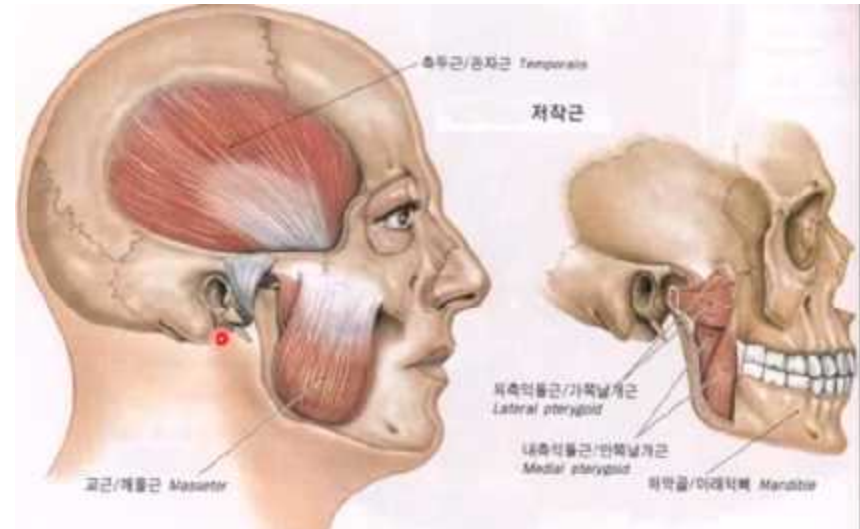
① 갑상연골 갑상선

② 경동맥

③ 쇄골두 목정맥패임

④ 유양돌기 후두골

⑤ 7번 경추 1번 흉추



유양돌기

외이도

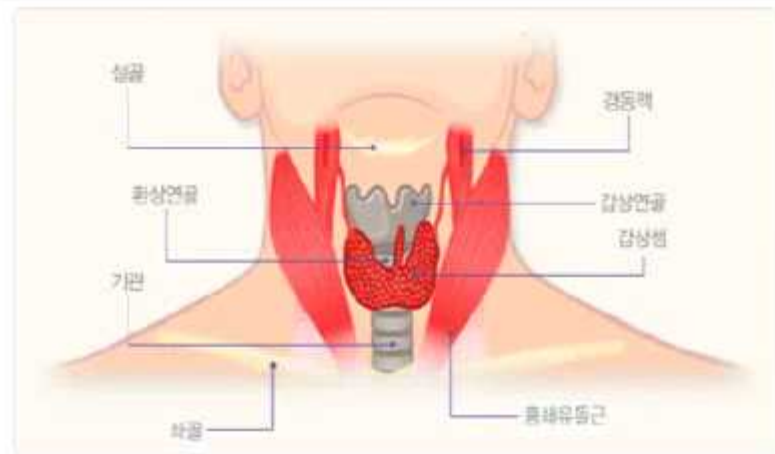
턱관절

교근 (우리 몸에서 힘이 가장 센 근)이 있고 그를 건어내면 또 그 심부의 근육들이 나타남

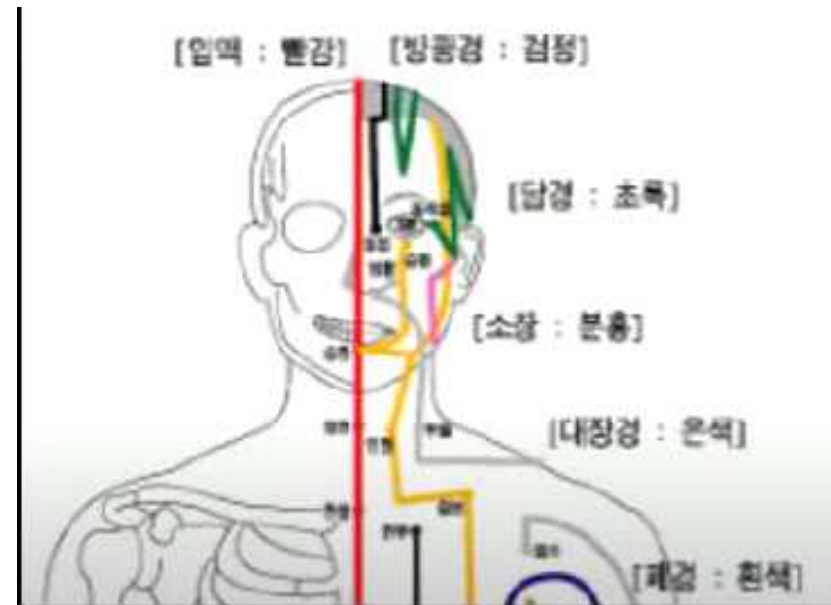
갑상선 구조물 참고



흉쇄유돌근 사이에 경동맥 존재



경락의 유주



안면부에서는 위경과 대장경이 가장 중요. 가장 많이 볼 수 있음.